ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРЕНИЕ



Средства, влияющие на аппетит, применяются для его повышения или снижения. Они входят в группу лекарственных средств, влияющих на пищеварение.

1 Средства, повышающие аппетит (горечи)

Средства, повышающие аппетит, называются горечами, поскольку имеют горький вкус.

Препараты:

- Настойка полыни.
- Настойка травы золототысячника.
- Настойка корня одуванчика.
- Корневище аира.
- Настойка трилистника водяного.
- Сок подорожника.





Полынь (настойка)



Золототысячник (настойка)



Одуванчик (настойка корня)



Аир (корневище)



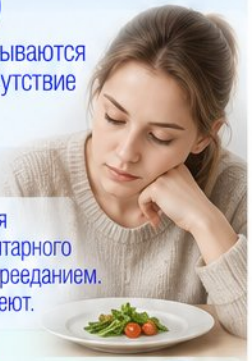
Трилистник водяной (настойка)



Подорожник (сок)

Назначают за 15–20 минут до еды для повышения аппетита. Одновременно усиливают выработку желчи и желудочного сока.

2 Средства, снижающие аппетит (анорексигенные)



Средства, снижающие аппетит, называются анорексигенными. Анорексия — отсутствие чувства голода.

Показания к применению

Анорексигенные средства применяются только в комплексном лечении алиментарного ожирения — ожирения, вызванного перееданием. Самостоятельного значения они не имеют.

Комплексное лечение включает:

- нормализацию режима питания;
- диету;
- работу с психотерапевтом при расстройствах пищевого поведения;
- нормализацию двигательной активности;
- возможно использование хирургических методов, например резекции желудка.

Препараты

Относятся к психостимуляторам, уменьшающим потребность в пище.

- Сибутрамин (Редуксин).
- Амфепрамон.



Важно знать:

- Возможны привыкание и выраженный синдром отмены.
- При применении только лекарственных средств после их отмены прежнее состояние возвращается и может стать ещё более выраженным.
- Анорексигенные препараты используются исключительно как часть комплексной терапии.

3 Сравнение средств, влияющих на аппетит

Характеристика	Средства, повышающие аппетит (горечи)	Средства, снижающие аппетит (анорексигенные)
Другое название	Горечи	Анорексигенные средства
Препараты (примеры)	Полынь, золототысячник, одуванчик, аир, трилистник водяной, подорожник	Сибутрамин (Редуксин), амфепрамон
Механизм действия	Усиливают выработку желчи и желудочного сока, повышают аппетит	Психостимулирующее действие, уменьшают потребность в пище
Показания	Снижение аппетита	Комплексное лечение алиментарного ожирения
Особенности применения	За 15–20 минут до еды	Только в составе комплексной терапии (диета, режим питания, психотерапия, физическая активность)
Особые указания	Имеют горький вкус	Возможны привыкание и синдром отмены, самостоятельного значения не имеют

ПРЕПАРАТЫ ПРИ ГИПЕРСЕКРЕЦИИ ЖЕЛУДКА

Гиперсекреция желудка — избыточная выработка соляной кислоты.
Она может приводить к гастриту, язвам, изжоге, отрыжке.

1 Что такое гиперсекреция желудка?

Гиперсекреция — это избыточная выработка соляной кислоты (HCl) в желудке. Повышенная кислотность может приводить к воспалению слизистой оболочки (гастриту), язвам, изжоге, отрыжке и другим неприятным симптомам.



2 Антацидные средства

Антациды нейтрализуют уже имеющуюся в желудке соляную кислоту. Название состоит из отрицательной приставки «ан-» и acidum — **«кислота»**.
Нейтрализация представляет собой реакцию кислоты и щёлочи.

На выработку соляной кислоты антациды **не влияют**: после приёма препарата **нейтрализуется** та порция кислоты, которая находится в желудке.

3 Механизм действия

Антациды взаимодействуют с соляной кислотой (HCl), находящейся в желудке, и нейтрализуют её, образуя соли и воду.



В результате снижается кислотность и уменьшаются неприятные симптомы (изжога, боль и др.).

4 Препараты

- Маалокс.
- Гевискон.
- Ренни.
- Альмагель.
- Гастал.



5 На основе каких веществ?

Основой антацидных препаратов служат **соли магния** или **алюминия**.

Соли магния
(Маалокс, Ренни и др.)



Соли алюминия
(Альмагель и др.)



6 Побочные эффекты

Соли магния

Основной побочный эффект — **диарея** (послабление стула).

Соли алюминия

Основной побочный эффект — **запор** (задержка стула).

7 Показания к применению



Язвенная болезнь



Гастрит



Изжога

Антациды применяются для уменьшения симптомов, связанных с повышенной кислотностью желудочного сока.

При выборе препарата учитывают:

- при склонности к запорам предпочтение отдают препарату на основе магния;
- при склонности к диарее — препарату на основе алюминия.

ИНГИБИТОРЫ СЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ПЕПСИНА

Эти препараты уменьшают выработку соляной кислоты и пепсина в желудке и применяются при заболеваниях, связанных с повышенной кислотностью.



1 Три группы препаратов

К ингибиторам секреции соляной кислоты и пепсина относятся:

1. М-холинолитики.
2. Блокаторы H_2-гистаминовых рецепторов.
3. Ингибиторы протонной помпы.

! Все три группы снижают выработку соляной кислоты, но действуют на разные звенья регуляции секреции.

2 М-холинолитики

Блокируют М-холинорецепторы, уменьшают влияние парасимпатической нервной системы и снижают секрецию соляной кислоты.

Препараты:

- Атропина сульфат.
- Платифиллин.
- Препараты белладонны.

Показаны при язвенной болезни, но после появления ингибиторов протонной помпы практически не применяются с этой целью.

! Причина — дополнительные, нежелательные в этой ситуации эффекты на бронхи, сердце и другие органы вместо избирательного действия на желудок.

3 Блокаторы H_2-гистаминовых рецепторов

Блокируют H_2-гистаминовые рецепторы желудка и снижают секрецию соляной кислоты.

Препараты:

- Ранитидин.
- Фамотидин.

Эту группу необходимо отличать от антигистаминных препаратов, блокирующих H_1-рецепторы.

Показания:

- Язвенная болезнь.
- Гастрит.
- Хеликобактерная инфекция.



4 Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Ингибиторы протонной помпы, или протонового насоса, — единственная группа с доказанной длительной эффективностью при лечении язвенной болезни. Они блокируют выработку соляной кислоты на продолжительный период.



4.1 Препараты



4.2 Показания


Гастрит


Язвенная болезнь


Хеликобактерная инфекция


Постоянная изжога

4.3 Применение для защиты желудка


За 30 минут до приёма

Ингибиторы протонной помпы также применяют при:

- приёме гастротоксичных средств (например, глюкокортикостероидов или НПВС);
- полипрагмазии — одновременном использовании большого количества лекарственных средств (например, у пожилых пациентов).

Приём защитного препарата — **за 30 минут.**

5 Побочные эффекты

- Привыкание.
- Синдром отмены.
- Боли в мышцах и суставах.
- Сухость во рту.
- Мышечная слабость.
- Тошнота.

После отмены препарата симптомы могут возвращаться.



6 Почему нельзя применять постоянно?

Постоянное применение может приводить к гипоацидному состоянию и гипоацидному гастриту:

- выработка соляной кислоты прекращается;
- ухудшается пищеварение и защитные функции желудка;
- способствует размножению бактериальной флоры.


Хеликобактер — кислотлюбивый

Большинство кишечных микроорганизмов не любит кислую среду. Хеликобактер, напротив, является кислотолюбивым и хорошо размножается в ней. Гипоацидное состояние также может сопровождаться воспалением.

ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ, ЖЕЛЧЕГОННЫЕ И ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Эти препараты защищают слизистую желудка, улучшают образование и отток желчи, а также поддерживают и восстанавливают клетки печени.



1 ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ

Гастропротекторы защищают желудок от повреждений. К ним относятся в том числе ингибиторы протонной помпы.

Ребамипид
улучшает регенерацию и кровоснабжение слизистой желудка, механически защищает её от возможных повреждений.



Другие средства этой группы:



Препараты простагландинов Е
- Сукральфат.

Простагландины необходимы для регенерации, пищеварения, кровоснабжения и восстановления слизистой оболочки.



Растительные средства
- Отвар семян льна.
- Препараты подорожника.
- Препараты зверобоя.



Препараты висмута — Де-Нол.
Образуют в желудке защитную плёнку, обволакивают слизистую, защищают её от повреждений и закрывают уже имеющиеся дефекты — язвы и эрозии, создавая условия для восстановления.

2 ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА

Желчегонные средства разделяются на группы в зависимости от действия на образование и отток желчи.

Желчь образуется в печени, накапливается в желчном пузыре и поступает в двенадцатиперстную кишку. Желчегонные средства могут усиливать её образование, улучшать отток или облегчать поступление желчи в кишечник.

1 Средства, усиливающие секрецию желчи в печени

Усиливают образование желчи в печени.

Препараты:
- Урсосан.
- Холосас.
- Холензим.
- Хофитол.
- Фламин.





2 Холеспазмолитики (улучшают отток желчи)

Расслабляют гладкую мускулатуру желчных путей, улучшают отток желчи из печени и желчного пузыря.

Препараты:
- Дротаверин (Но-шпа).
- Дюспаталин.

Но-шпа воздействует на всю гладкую мускулатуру: кишечник, желчевыводящие пути, мочевой пузырь, матку.

Дюспаталин — более современный препарат, предпочтительный по сравнению с Но-шпой в данном случае.



3 Средства, улучшающие отхождение желчи в двенадцатиперстную кишку

Расслабляют сфинктер Одди — сфинктер между общим желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой, обеспечивая поступление желчи в кишечник.

Препараты:
- Сульфат магния (магнезия).





3 ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Гепатопротективные средства применяются при циррозе печени, гепатитах и токсических поражениях печени лекарствами, ядами, алкоголем.



Основные группы препаратов:

Фосфолипиды
- Эссенциале.
- Фосфоглив.



Урсодезоксихолевая кислота
- Урсосан.
- Урсофальк.



Препараты расторопши пятнистой
- Карсил.



Препараты артишока
- Хофитол.



- Поддерживают и защищают клетки печени.
- Способствуют восстановлению её функции.
- Применяются при циррозе, гепатитах и токсических поражениях печени лекарствами, ядами, алкоголем.

ПРЕПАРАТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА



Препараты, регулирующие моторику кишечника, делятся на антидиарейные и слабительные.

1 Антидиарейные средства

Показание — диарея: учащённый жидкий стул.
Средства различаются по механизму устранения диареи.

1.1 Сорбенты

Проходя через пищеварительный тракт, попадают в кишечник и собирают на своей поверхности вещества, подлежащие выведению. Сорбироваться могут жидкие, твёрдые и газообразные вещества.

- Активированный уголь.
- Смектит (Смекта).
- Полисорб.
- Энтеросгель.



1.2 Кишечные антисептики

Уничтожают возбудителей диареи — бактерий и вирусов, а не блокируют перистальтику.

- Энтерофурил.
- Фуразолидон.



1.3 Истинные антидиарейные средства

Блокируют перистальтику кишечника и тем самым закрепляют стул.

- Лоперамид (Имодиум).



! Лоперамид **запрещён** при **бактериальной** и вирусной **диарее**, в том числе при ротавирусной инфекции. Подавление перистальтики задерживает кишечное содержимое вместе с возбудителями и может приводить к осложнениям.

1.4 Пеногасители

Блокируют образование газа в кишечнике.

- Эспумизан.





1.5 Пробиотики и пребиотики

Препараты живых или ослабленных бактерий, лактобактерий либо веществ, необходимых для их питания и улучшения жизнедеятельности. Используются при диарее, возникающей вследствие дисбактериоза.

- Бифидумбактерин.
- Линекс.
- Бифиформ.
- Баксет.
- Энтерол.



2 Слабительные средства

Слабительные средства делятся на группы в зависимости от механизма действия.

2.1 Размягчающие каловые массы

Преимущественно масла растительного или синтетического происхождения. Могут применяться в жидком виде, капсулах или клизмах.

- Подсолнечное масло.
- Оливковое масло.
- Касторовое масло.
- Вазелиновое масло.
- Льняное масло.



2.2 Средства, раздражающие рецепторы кишечника

Стимулируют перистальтику, раздражая рецепторы кишечника.

- Препараты сенны.
- Препараты ревеня.
- Препараты крушины.
- Бисакодил.
- Препараты лактулозы (наиболее безопасные, применяются у детей и беременных).



2.3 Средства, увеличивающие объём химуса

Увеличивают объём пищевого комка (химуса) за счёт клетчатки и других объёмных веществ.

- Отруби.
- Клетчатка.
- Семена чиа и льна.
- Подорожник.
- Порошок ламинарии (морской капусты).
- Плоды сливы и инжира.
- Препарат: Регулакс.



2.4 Осмотические слабительные

Увеличивают объём химуса за счёт жидкости. Основное применение — очищение кишечника перед эндоскопическими исследованиями, например колоноскопией.

- Фортранс.
- Эзиклен.



Могут быть на основе солей магния или натрия. Порошок разводят водой, полученный раствор выпивают. В этот день больше ничего не принимают; происходит полное очищение тонкого и толстого кишечника, необходимое для исследования.

3 Краткое сравнение основных групп

Группа	Механизм действия	Примеры	Показания / применение
Сорбенты	Собирают на поверхности вещества	Активированный уголь, Смекта, Полисорб, Энтеросгель	Диарея (бактериальная, вирусная, пищевая)
Кишечные антисептики	Уничтожают возбудителей (бактерии, вирусы)	Энтерофурил, фуразолидон	Диарея инфекционного происхождения
Противодиарейные (истинные)	Блокируют перистальтику кишечника	Лоперамид (Имодиум)	Диарея неинфекционного происхождения (запрещены при бактериальной и вирусной диарее)
Пеногасители	Блокируют образование газа	Эспумизан	Вздутие, метеоризм
Пробиотики и пребиотики	Нормализуют микрофлору кишечника	Бифидумбактерин, Линекс, Бифиформ, Баксет, Энтерол	Диарея при дисбактериозе
Размягчающие каловые массы	Размягчают содержимое кишечника	Растительные и синтетические масла	Запор
Раздражающие рецепторы	Стимулируют перистальтику	Сенна, ревень, крушина, бисакодил, лактулоза	Запор
Увеличивающие объём химуса	Увеличивают объём пищевого комка	Отруби, клетчатка, чиа, лён, подорожник, ламинария, Регулакс	Запор
Осмотические слабительные	Увеличивают объём химуса за счёт жидкости	Фортранс, Эзиклен	Очищение кишечника перед колоноскопией